

9 - Cancers de la cavité buccale - Pr. Aziz

Normalement, c'est un sujet qui doit être traité ce soir, mais bon. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis professeur Aziz, je suis professeur en chirurgie maxillofaciale et esthétique de la face à l'hôpital d'Ottawa et j'ai la lourde tâche de vous enseigner ce cours qui est les cancers de la cavité buccale. C'est un cours qui est très important.

Pourquoi il est important ? D'abord pour votre examen, bien sûr. Et après, parce que c'est une pathologie qui est très fréquente malheureusement chez nous au Maroc et qui entraîne des séquelles aussi bien fonctionnelles que morphologiques dans notre contexte marocain. Donc, les cancers de la cavité buccale sont définis comme toute néo-formation avec prolifération cellulaire maligne qui naît ou qui siège au niveau de la cavité buccale.

Comme tout cancer, c'est des proliférations de cellules anarchiquement. C'est une pathologie fréquente dans notre contexte. C'est la pathologie la plus fréquente des cancers des voies aérodigestives supérieures vu qu'elle représente 30% de ces cancers.

Elle est due essentiellement à l'intoxication alcool-tabagique. Il faut savoir que l'association entre alcool et tabac multiplie ce risque de cancer de six fois. Sur le plan histologique, ils sont dominés par le carcinome épidermoïde en 90% des cas.

Elle est grave vu son extension rapide, vu sa lymphophilie, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs qui s'étendent rapidement par les voies de drainage lymphatiques cervicales et en outre vont entraîner des métastases à distance. C'est la deuxième... Il faut savoir aussi qu'il y a souvent une deuxième localisation au niveau du pharynx ou au niveau même de la cavité buccale et ils sont gravés d'une mortalité très importante. Leur diagnostic se pose par l'examen clinique, qu'il faut bien faire, repose sur une biopsie avec examen anatomopathologique et bien sûr impose une prise en charge multidisciplinaire qui fait intervenir plusieurs intervenants, notamment le chirurgien, le réanimateur, l'oncologue et tout autre intervenant dans cette pathologie.

La prévention est toujours de mise afin de diminuer la gravité de cette pathologie. Donc au terme de ce cours, vous devez être capable normalement de rappeler les facteurs de risque d'un cancer de la cavité buccale, de mener un examen clinique bien conduit devant cette pathologie, de reconnaître les signes d'appel devant une lésion de la cavité buccale, de poser les différentes indications des examens complémentaires nécessaires pour le diagnostic, de résumer les particularités des formes cliniques, de citer les principes thérapeutiques, vous n'allez pas opérer bien sûr, mais au moins il faut connaître les différents types de moyens de prise en charge de cette pathologie et en dernier lieu de déterminer les niveaux de prévention et de dépistage de ces cancers. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant, après un bref rappel anatomique et histologique, nous allons passer à l'épidémiologie, l'anatomopathologie, par la suite l'étude clinique-paraclinique, les formes cliniques et les diagnostics différentiels, le traitement, puis la surveillance avant de conclure notre cours.

Pour le rappel, je pense que vous avez déjà fait l'anatomie maxillofaciale, mais un brève rappel de ce qui concerne la cavité buccale, il faut savoir, comme vous le savez tous, la cavité buccale constitue la partie initiale de l'appareil digestif, elle est située au niveau de l'extrémité céphalique, au-dessous des cavités nasales et du maxillaire et des sinus maxillaires, et de ce fait, toute tumeur de la cavité buccale peut s'étendre vers aussi bien les fosses nasales, le maxillaire, voire même l'orbite et la base du crâne, d'où la gravité de ces tumeurs. Elle communique en avant avec le milieu extérieur par l'orifice buccal, communique en arrière avec le pharynx par l'isthme du gosier. Je me suis oublié ou là-dedans ? Oui, l'isthme du gosier.

Tout ce que vous voyez, vous avez la luette en haut, vous avez la luette et normalement l'isthme du gosier, les deux pédicules, les deux piliers plutôt, il y a un pilier postérieur et un pilier antérieur. Désolé, je n'ai pas de pointeur. Ah oui, l'isthme du gosier, c'est ça.

On appelle l'isthme du gosier. Il y a deux piliers, un pilier postérieur et un pilier antérieur, entre les deux, qu'elle les amygdales. D'accord.

Donc schématiquement, la cavité buccale est constituée de six parois. On a une paroi antérieure constituée par les lèvres supérieures et inférieures, et entre les deux, on a la commissure labiale, d'accord, ici, puis la paroi postérieure, c'est l'isthme du gosier. Les parois latérales, c'est quoi les parois latérales de la cavité buccale ? C'est la face interne de joues, la paroi supérieure, le palais en avant et en arrière, le dur et le mou, comment on appelle le palais mou en arrière ? C'est le voile du palais, d'accord.

En bas, on a le plancher buccal qui supporte quoi ? La langue, d'accord. Pour la langue, il faut savoir qu'elle est constituée d'une face ventrale dorsale, de deux bords latéraux et d'une pointe. Elle est divisée en deux parties, néanmoins, la langue mobile et la base de langue.

Normalement, selon certaines classifications, c'est la partie mobile qui appartient à la cavité buccale. La partie postérieure appartient normalement aux pharynxes, d'accord. Les deux parties sont séparées par ce qu'on appelle le vilingual, que vous voyez ici, sur quelques papus.

La cavité buccale, de ce fait, elle participe à plusieurs fonctions, à savoir, quelles sont les fonctions de la cavité buccale ? L'alimentation, surtout on a la mastication, l'insalivation, on a la gustation, vu la présence de la langue et on a la phonation. Donc, toutes ces fonctions risquent d'être altérées en cas d'atteinte des structures de la cavité buccale, d'accord. En plus de ça, on a normalement les arcades dentaires supérieures et inférieures qui comprennent les dents et qui sont entourées par la gencive.

Cette gencive, il faut savoir qu'au niveau des dents et au niveau du palais, elle est attachée à l'os. Et de ce fait, toutes les ions qui siègent au niveau de la gencive, au niveau de la muqueuse palatine, vont s'étendre rapidement vers les structures osseuses, entraînant plusieurs dégâts. D'accord ? La vascularisation artérielle de la cavité buccale est assurée par les branches de la

carotide et veineuse, et ce drain vert, la veine jugulaire interne, d'accord, pour ce qui est d'innervation, l'innervation motrice est assurée par quoi ? Par le 7. Elle assure essentiellement la motricité des faces internes de joues.

On a également le nerf hypogloss qui assure la motricité de la langue. Pour la sensibilité, on a le 5 et le 5. Le 5.1, le 5.3 et le 5.2. Le 5.3 assure surtout la sensibilité de la partie inférieure des faces de la joue et le 5.2 assure la partie supérieure. Pour la partie montonnaire, c'est également le 5.2. Pour le drainage lymphatique, il est assuré par les chaînes jugulocarotidiennes cervicales, par les chaînes submandibulaires, sous-montonnaires et rétrospinales, comme vous voyez sur le schéma.

Normalement, les chaînes ganglionnaires sont scindées en chiffres. On voit ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Normalement, c'est cette schématisation qu'on utilise pour l'écurage ganglionnaire qu'on va voir par la suite. Tout va bien jusqu'à maintenant, n'est-ce-t-il mademoiselle ? Ce qui est histologie, il faut savoir que le revêtement muqueux de la cavité buccale est constitué d'un épithélium malpighien, pavimenteux, stratifié, peu kératinisé.

Puis, on a une lame basale ou membrane basale, au-dessous de laquelle on a un tissu conjonctif qui est le corion, constitué par un tissu conjonctif, par des vaisseaux, par des glandes salivaires accessoires. Il faut savoir, comme on a dit déjà, cette muqueuse est très attachée au niveau de la gencive et au niveau du palais osseux. Après, on passera à l'épidémiologie.

Il faut savoir que les cancers de la cavité buccale constituent la première localisation des cancers des voies aérodigestives supérieures avec un pourcentage presque de 30%. Là, généralement, il s'agit d'au-delà de 50 ans chez les sujets masculins. On a une augmentation de l'incidence mondiale du cancer de la cavité buccale chez la femme vu la modernisation et vu que les femmes le quittent mieux au Xèphe, malheureusement.

Donc, la langue mobile et le plancher sont les plus touchés et le carcinome épidermoïde constitue 90% de ces cancers. Les facteurs de risque les plus importants sont essentiellement le tabac, au-delà de 20 paquets à l'année. Le risque avec l'alcool est multiplié de 6 fois si on a une association entre le tabac et l'alcool.

On a également les infections virales, essentiellement l'HPV. Il faut savoir que vous êtes au courant qu'actuellement, ils ont instauré une vaccination contre l'HPV chez les jeunes filles, normalement pour le cancer buccal, mais ça aura un grand attentisme aussi sur le cancer de la cavité buccale, on espère bien. Il faut savoir aussi qu'il y a certains pays comme le Canada et l'Amérique, ils ont même instauré la vaccination pour l'homme contre l'HPV.

On a également l'exposition solaire, surtout pour les cancers de la lèvre. On a le mauvais état buccodentaire et les traumatismes répétés. Ces traumatismes répétés, c'est presque la principale cause qu'on voit dans notre service parce qu'on a souvent des patients avec des prothèses dentaires, ces prothèses généralement entraînent des traumatismes au niveau de la gencive, les

patients laissent les lésions qui sécrétisent pendant un certain moment et par la suite ils développent des cancers avec des stades le plus souvent avancés.

D'autres facteurs, c'est les facteurs nutritionnels, les mutations génétiques, l'exposition professionnelle et les inflammations chroniques. Ces différents facteurs de risque vont entraîner au début ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Actuellement, on les appelle les lésions à potentiel malin de la cavité buccale.

Ce sont des lésions qui précèdent le cancer. Ce ne sont pas des lésions cancéreuses, mais elles surviennent avant le cancer. Si on arrive à diagnostiquer ces lésions avant l'arrivée du cancer, on aura généralement une prise en charge meilleure que ce qu'on a actuellement.

Ces lésions sont définies par l'OMS comme un tissu morphologiquement altéré au sein duquel un cancer apparaît plus souvent que dans le tissu normal autologue, c'est-à-dire qu'il prédispose à un cancer. Ces lésions sont de deux types, on a les lésions blanches, les leucoplasies, je pense que vous avez déjà entendu parler des leucoplasies, et on a les lésions rouges, les érythroplasies. Les leucoplasies sont des lésions qui sont fixes, qui ne se détachent pas par le grattage.

Elles peuvent être soit homogènes, c'est le plus fréquent, avec un risque moins pour transformation cancéreuse, et elles peuvent être inhomogènes, avec plus d'inflammation à surface irrégulière, ce sont les lésions sur lesquelles se grevent généralement les cancers. Il faut normalement diagnostiquer ces cancers, ces lésions, à un stade avancé, comme ce que vous voyez sur l'image, c'est l'image d'une leucoplasie inhomogène, très étendue, avec un grand risque de transformation maligne. Parmi les leucoplasies, je pense que vous avez déjà étudié les leucoplasies en dermatose, non ? Les lésions blanches, les érythroplasies, non ? Parmi les leucoplasies, on a le lécynplan, c'est le plus fréquent, c'est une maladie qui est inflammatoire, chronique, qui évolue par poussée.

En dehors des poussées, généralement, c'est des lésions qui sont blanchâtres, qui sont circonscrites, réticulées ou dendritiques, comme ce qu'on voit sur l'image en haut, vous voyez, c'est des lésions qu'on appelle dendritiques. Après, pendant les poussées, il devient plus érythémateux, comme vous voyez sur l'image en bas, mais également, on a des lésions qui sont un petit peu circonscrites, qui sont érosives. Les formes anciennes entraînent une atrophie ou une forme, ce qu'on appelle verruqueuse.

La forme verruqueuse, c'est, on a un aspect en forme de touffe de poils, bien à l'intérieur de la bouche. Le lécynplane présente une dégénérescence manique qui reste rare. Après, on a la leucoplasie proliférative verruqueuse, c'est ce que je vous ai dit, comme les touffes de poils.

Vous voyez sur l'image, c'est blanchâtre sur la bouche. Ce sont des lésions qui sont rugueuses, souples à la palpation, qui touchent préférentiellement le sujet âgé, avec un placard

papillomateux étendu. Ils se transforment généralement vers ce qu'on appelle un carcinome verruqueux ou bien elles peuvent se transformer même vers un carcinome épidermoïde.

Le traitement d'un homme, c'est l'exérèse itérative dès qu'on l'évoque. Par la suite, on a la kératose actinique labia, ce sont des lésions qui siègent essentiellement au niveau de la lèvre inférieure et sont dues essentiellement à l'exposition solaire et aussi au tava. On a un aspect desquamatif réactionnel, elles évoluent vers une hyperkératose fissuraire, on a un aspect de fissure au niveau de la lèvre.

Le traitement, généralement, c'est l'arrêt du tabac. Des fois, à l'arrêt du tabac, ces lésions peuvent disparaître, mais si on a une persistance des lésions, il faut réaliser une exérèse dès que possible. Après les leucoplasies, on a les érythroplasies ou les lésions rouges.

C'est une plaque qui est veloutée, rouge brillante, uniforme, avec des limites qui sont le plus souvent nettes, ce n'est pas des limites qui sont irrégulières. Souvent, elles sont étendues et on n'a pas de douleur. Elles sont plus rares que les leucoplasies, mais avec un risque plus important de dégénérer sans ce tumor.

Pour les autres lésions, on a la fibrose orase ou muqueuse, c'est une fibrose. On a une muqueuse qui est dure, blanchâtre, il faut également l'enlever. On a les candidoses chroniques, on a le lupus érythémate discouïde et d'autres lésions.

Les lésions ont un potentiel malin, elles nécessitent une surveillance stricte. Il faut réaliser une biopsie dès qu'on a cette lésion pour confirmer leur diagnostic qui n'est pas malin. Elles peuvent être spontanément résolutive à l'arrêt du facteur favorisant, mais ce n'est pas toujours le cas.

Il faut les surveiller, même si on demande au patient par exemple d'arrêter le tabac ou d'arrêter l'alcool, il faut surveiller le patient avec un suivi régulier, sinon on risque une transformation maligne. Et il nécessite une exercice chirurgicale si le risque est important, bien sûr, de transformation. Le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate de ces lésions va diminuer de 50 % normalement le risque de cancer de la cavité buccale.

On passe maintenant à tout ce qui est à l'entomopathologie. Pour l'entomopathologie, on commencera par la microscopie. Dans la microscopie, normalement, dans les tumeurs de la cavité buccale, on a les tumeurs épithéliales et on a les tumeurs non épithéliales.

Pour les tumeurs épithéliales, c'est le carcinome épidermoïde dans 90 % des cas. Il reproduit de façon plus ou moins fidèle la structure d'un épithélium malpighien, mais avec une prolifération qui est plus anarchique. Ces cancers peuvent siéger au niveau de l'épithélium, on parle alors d'épithélium in situ, il est intraépithélial.

Il peut remplir la membrane basale, et là on parle de micro-invasif, et s'il arrive au niveau des structures adjacentes, on parle de cancer invasif. Invasif, normalement, il s'étend vers tout ce qui

est os, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est peau. Une fois on a une atteinte musculaire, on parle d'un cancer invasif en fonction de la localisation de la tumeur.

Ce cancer peut être peu, moyennement, ou bien différencié en fonction de la tumeur. Il existe certaines variantes du carcinome épidermoïde, ce n'est pas très important de retenir les différentes variantes, mais bon, pour que vous connaissiez différentes formes. Elles peuvent être soit fusiformes, dont le diagnostic est difficile, et généralement ils sont diagnostiqués comme des sarcomes, elles peuvent être basaloïdes, elles sont plus agressives, papillaires, adénosquameux, acantholytiques ou cuniculatomes.

Il existe également ce qu'on appelle le carcinome lymphoépithélial, il y en a certains qui l'intègrent dans le carcinome épidermoïde, et certains qui le différencient du carcinome épidermoïde, mais gardez à l'esprit que le principal diagnostic et le principal cancer de la cavité buccale, c'est le carcinome épidermoïde. Pour les tumeurs non épithéliales, il faut savoir, comme on l'a vu en fluistologie, que la muqueuse buccale contient des glandes salivaires, et généralement c'est la deuxième tumeur qui vient après le carcinome épidermoïde, c'est les carcinomes glandulaires, ils sont plus rares, mais on a essentiellement l'adénocarcinome et le carcinome adénoïde qui se greffent sur les glandes salivaires accessoires, et la localisation la plus fréquente est la localisation palatine, mais toutefois on peut avoir des localisations linguales ou bien des localisations au niveau de la face interne de la joue. Les autres tumeurs, c'est les sarcomes, les ostéosarcomes, chondrosarcomes, fibrosarcomes ou autres, on a également les lymphomes, on peut avoir même des mélanomes, comme sur cette image, on a un mélanome de la gencive maxillaire avec extension au niveau du palais, ce sont des tumeurs qui sont très graves, avec une extension et une agressivité locale très importante et généralement la prise en charge de ces tumeurs est vraiment très lourde.

On va avoir un sarcome de Kaposi en cas de VIH et des métastases d'une autre tumeur, la cavité buccale peut être siège d'un primitif autre qu'au niveau de la cavité buccale. Après la microscopie, on a la macroscopie, il faut garder à l'esprit ces différentes images, on a tout d'abord l'ulcération, on a un bord qui est plus ou moins irrégulier, surélevé et parfois même inversé, il est recouvert de muqueuses normalement saines ou inflammatoires et parfois on peut avoir une forme de fissure au niveau de la muqueuse. Le deuxième aspect c'est le bourgeon, comme ce qu'on voit sur cette image, on a une lésion bourgeonnante au niveau du bord latéral de la langue, ce sont des lésions qui sont dénuées de muqueuses contrairement à l'ulcération, friables, plus ou moins exubérantes et puis ce sont des tumeurs qui sont saignantes au contact, dès qu'on les touche, elles commencent à saigner contrairement à l'ulcération.

La forme la plus fréquente c'est l'association des deux, c'est l'association de lésions bourgeonnantes et ulcérées qu'on appelle lésions ulcéro-bourgeonnantes comme ce qu'on voit sur l'image au milieu, on a un bourgeon très évolué avec une ulcération à l'intérieur. Il faut savoir que les étudiants en 7ème année, les écosses, on met des images de tumeurs de la cavité buccale et qu'ils n'arrivent pas à faire la description de ces lésions, ils ne différencient pas entre

ce qui est bourgeon, ce qui est ulcérée, ce qui est ulcéro-bourgeonnant. Et le quatrième c'est le nodule interstitiel, c'est un nodule qui est sous-muqueux et le plus souvent il est d'origine glandulaire.

Pas de question ? C'est bien ? D'accord. Les tumeurs et les cancers de la cavité buccale, comme tout cancer, s'étendent dans les structures adjacentes. On parle alors d'une extension nocorrégionale, soit vers la peau, le muscle ou bien l'os sous-jacent.

Par exemple, les tumeurs de la gencive ou du vestibule mandibulaire qui s'étendent vers la mandible. Elles peuvent être aussi lymphatiques, donnant des ganglions métastatiques ou bien on peut avoir une extension à distance et donner des métastases essentiellement pulmonaires. Généralement quand on a des métastases, le patient n'est plus opérable, c'est l'apprenage de la radiothérapie et de la chimiothérapie.

La cavité buccale est constituée de plusieurs parties comme on a vu, c'est six parois et ces six parois présentent des lésions différentes sur le plan forme. On a la langue mobile qui est la plus fréquente, on a suivi du plancher buccal, on a le versant muqueux de la lèvre, essentiellement la lèvre inférieure, on a également la face interne de joues, on a la commissure intermaxillaire, la commissure intermaxillaire on l'appelle également le trigone métromolaire, j'ai oublié de le mentionner dans le rappel anatomique, c'est cette partie postérieure. Les lésions du trigone métromolaire sont diagnostiquées tardivement, c'est des lésions généralement très avancées et malheureusement l'extension est rapide vu que cette zone est tout près de la base du crâne parce que la branche montante de la mandibule.

Généralement on a une extension vers la mandibule, vers le canal dentaire et par la suite vers la base du crâne. On a également le palé dur et puis les tumeurs de la gencive. Après ces différents rappels épidémiologie et anatomopathologie, on passe à notre étude clinique qui est très importante pour moi et aussi pour vous pour permettre le diagnostic de ces tumeurs.

Les circonstances de découverte sont multiples et variées, généralement dans notre service et dans notre contexte ce sont les formes évoluées. Ces formes évoluées, on a comme circonstances de diagnostic le trismus, on a les fractures pathologiques, on a les fistules orocutanées, c'est-à-dire qu'on a une fistule au niveau par exemple de la joue, au niveau du menton, suite à une tumeur endobuccale. On a également les gênes, vu les différentes fonctions de la cavité buccale, donc on peut avoir un gêne à la mastication, à la protraction de la langue, à la déglutition, l'élocution ou bien à l'ouverture buccale.

On peut avoir des otalgies réflexes, vu la proximité des lésions, surtout s'ils sont postérieurs avec le candidat. On peut avoir des odinophagies, l'odinophagie c'est la douleur à la déglutition, on peut avoir des stomatoragies, des odontalgies ou bien des glossodynies, c'est les douleurs de la langue, l'aléophétie, elle est fréquente, on peut avoir des adénopathies cervicales, quand vous avez un patient avec des adénopathies cervicales, il faut toujours faire un examen de la cavité

buccale à la recherche d'un cancer. On peut avoir des picotements aux brûlures à l'ingestion d'aliments épicés ou d'alcool, la sensation de corps étranger, il existe également les signes dentaires, il faut savoir qu'une mobilité ou chute dentaire sans raison valable, c'est une circonstance de diagnostic alarmante.

On peut avoir une adaptation d'une prothèse dentaire, un retard de cicatrisation alvéolaire ou bien une malposition dentaire récente. La découverte fortuite reste rare, soit par le patient lui-même qui trouve une lésion, une petite lésion endobuccale, mais c'est rarement le cas. Lors d'un examen dentaire, surtout chez les dentistes, des fois on a des patients qui viennent adressés par des dentistes ou bien lors d'un bilan d'extension d'un autre cancer des voies aérodigestives supérieures parce que dans la majorité des cas, quand on a un cancer des voies aérodigestives supérieures, on a une deuxième localisation qui peut siéger au niveau de la cavité buccale ou bien lors de la surveillance d'une lésion précancéreuse connue.

Par exemple, on a un liquelplan qu'on suit et au cours de la surveillance, on peut avoir une implantation d'un cancer au-dessus de la lésion. Pour l'examen maxillofacial, il débutera bien sûr par un interrogatoire qui doit préciser le terrain, les antécédents personnels essentiellement toxico-allergiques, la notion de lésion précancéreuse traitée ou suivie, les cancers des voies aérodigestives supérieures, une radio-thérapie ou chimio-thérapie ultérieure, il doit préciser également les tards et les comorbidités du patient, l'histoire de la maladie et de la lésion, la date de début de la lésion, le mode de début, est-ce qu'il est un mode qui est brutal ou bien chronique et l'évolution, est-ce qu'elle est rapide ou non ? Recherchez toujours la notion d'asthémie, d'anorexie et surtout l'altération de l'état général récente qui oriente toujours vers un cancer. Après l'interrogatoire, on passera à l'examen clinique.

L'examen clinique passe par deux examens importants, à savoir l'examen endobuccal et l'examen exobuccal pour les gens qui étaient au service. Donc l'examen endobuccal, il doit être méthodique, avec un bon éclairage, abaisse-langue, miroir, gants, les muqueuses déplacées, il faut savoir qu'au niveau de la bouche, généralement on a plusieurs muqueuses qui sont déplacées, il faut toujours les déplacer à la recherche de lésions, surtout au niveau du plancher et au niveau de la face interne de la joue. Donc vous voyez ici, sur cette image, il tire un petit peu sur la joue pour déplacer le trigone rétro-molaire qui est là, d'accord ? Il faut aussi tirer la langue à la recherche de lésions un petit peu plus postérieure.

Par la suite, on a le toucher bidigital et digital et il faut enlever toute prothèse dentaire avant l'examen clinique endobuccal. Toutes ces notions doivent être schématisées sur un schéma qui est daté. L'inspection, on va préciser le siège de la lésion, préciser sa taille apparente parce qu'il faut savoir qu'une lésion à l'inspection, ce n'est pas la lésion à la palpation, ça vous le saviez ou non ? On parle d'un filtre d'induration, donc le terme c'est l'induration et généralement l'induration est plus grande que ce qu'on voit sur l'inspection, d'accord ? C'est le truc de l'iceberg, donc on voit le sommet mais à l'intérieur la lésion est très infiltrante et c'est parmi les signes de présomption d'une tumeur.

Donc après préciser l'aspect de la lésion, est-ce qu'elle est ulcérée, bourgeonnante, ulcéro-bourgeonnante ou bien nodulaire, les rapports avec les structures, rechercher une autre lésion pré-cancéreuse parce qu'il faut savoir qu'un patient qui présente un cancer par exemple de la langue peut présenter une deuxième localisation au niveau de la face interne de la joue, donc il ne faut pas passer à côté d'une deuxième localisation. Rechercher un saignement ou surinfection, une limitation de l'ouverture buccale, généralement en mesure par un pied à coulisses ou bien par les doigts et rechercher une limitation de la protraction linguale et apprécier l'état bucodentaire de notre patient. A la palpation, elle doit être douce et prudente, le palpé est digital et bidigital, il va préciser la taille de l'induration, il faut la noter sur un schéma aussi, généralement l'induration dépasse toujours la taille à l'inspection, c'est ainsi comme je l'ai dit tout à l'heure de présomption de malignité.

Rechercher une douleur à un saignement au contact, surtout dans les lésions bourgeonnantes, rechercher une mobilité dentaire et l'infiltration des structures adjacentes. L'examen exo-buccal va apprécier les téguments, il va rechercher notamment une infiltration cutanée inflammatoire, un oedème, il doit rechercher un nodule ou fistule comme ce qu'on a sur cette image, on a une fistule jugale faisant suite à un carcinome épidermique de la face interne de la joue et généralement dans les fistules on a une issue de pus. Il faut rechercher aussi les reliefs osseux, par la suite passer à un examen neurologique, il ne faut jamais oublier un examen neurologique devant un cancer de la cavité buccale, vu qu'on peut avoir une extension au niveau du 5-3 qui passe à l'intérieur de la mandibule, donc si on a un cancer qui siège au niveau de la gencive mandibulaire avec une extension mandibulaire, on aura dans la majorité des cas une insensibilité au niveau de la lèvre inférieure et du menton, donc vous touchez le patient, vous allez sentir, est-ce qu'il ressent sa lèvre, est-ce qu'il ressent son menton, on parle de signe de Vincent, d'accord, parce qu'il faut savoir que parmi les critères de gravité d'un cancer de la gencive mandibulaire, c'est l'atteinte neurologique, parce que le nerf passe à l'intérieur du canal dentaire et le canal dentaire il part jusqu'à la base du crâne, donc la tumeur risque d'évoluer à travers le canal et d'arriver au niveau de la base du crâne.

Appréciez également la mimique faciale à la recherche d'une atteinte du nerf facial, surtout dans les tumeurs de la face interne de la joue, et puis appréciez le goût en cas d'atteinte du nerf lingual. L'examen des ergans glionaires est systématique devant une tumeur de la cavité buccale, il doit rechercher les adénopathies cervicales, normalement on se place derrière le patient et on fait un examen minutieux de toute la région cervicale et sous-mandibulaire à la recherche d'une adénopathie. Et en cas d'adénopathie, il faut toujours préciser le siège, est-ce qu'elle est unie ou bilatérale, préciser sa taille, le nombre, la consistance, la sensibilité, la mobilité et l'état de la peau en regard à la recherche d'une éventuelle adénopathie métastatique.

Quels sont les critères d'une adénopathie tumorale ? La fixité, rond, dur, inflammatoire, on a une peau généralement qui est inflammatoire, fixe, on l'a déjà dit, et douloureuse. Généralement c'est

des adénopathies qui sont douloureuses. Donc si on a ces critères, il y a une forte probabilité que la tumeur s'étend au niveau des aires ganglionnaires.

Et puis il faut noter tout ça sur un schéma daté. L'examen ORL est systématique à la recherche d'une deuxième localisation au niveau de l'oropharynx, de l'orynx ou l'hypopharynx. Il doit être complet et normalement on réalise systématiquement une palendoscopie si on a une lésion de la cavité buccale.

L'examen général pour apprécier l'état général, les comorbidités et rechercher l'éventuel métastase. Donc l'examen clinique, l'objectif de cet examen est de rechercher les signes de présomption de malignité, à savoir l'érosion, l'ulcération, l'induration ou lésion chronique qui devient douloureuse ou saignante au contact. Et en même temps cet examen clinique permettra de réaliser un premier bilan d'extension loco-régional.

Après notre étude clinique, on passera à l'étude paraclinique. Quel est le premier examen paraclinique qu'on demande pour l'examen devant une lésion endobulaire? C'est la biopsie. Biopsie est une étude anatomopathologique, question d'examen clinique.

C'est la biopsie avec étude anatomopathologique, c'est un examen clé, il permet de confirmer le diagnostic. C'est le seul examen de certitude tumorale, c'est pas la TDM, c'est pas la panoramique, c'est pas l'IRM qui va dire qu'on a un cancer, mais c'est la biopsie. La biopsie peut être réalisée sous anesthésie locale si la lésion est accessible, mais on peut la faire sous anesthésie générale si on a une lésion, par exemple, postérieure ou s'il y a un risque pour le patient.

Il faut savoir que dans votre cabinet, ce qui reste généraliste, vous pouvez faire une biopsie pour ne pas retarder la prise en charge du patient. La biopsie est réalisée entre jonction saine et jonction tumorale, vous saviez ça ? Avec les conditions bien sûr de sécurité, aussi bien pour vous que pour le patient. Généralement, la biopsie ne doit pas retarder la prise en charge des patients.

C'est à dire que si vous voyez un patient avec une lésion suspecte, il faut activer les choses. Si c'est rendez-vous à la consultation au service de chirurgie maxillofascienne, il va recevoir trois mois de rendez-vous. Après trois mois, soit il va décéder, soit il va venir avec une lésion qui a triplé de taille.

Donc si vous voyez une tumeur, soit vous faites la biopsie, soit vous ne pouvez pas faire la biopsie, mais vous l'orientez aux urgences. D'accord ? Comme quoi c'est un truc qui est urgent. Parce que généralement, les patients qui sont à un stade très évolué malheureusement, alors que ce sont des petites lésions, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est une petite ulcération.

C'est un petit bourgeon, c'est un petit nodule. Mais généralement, ce qu'on opère dans notre service, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer quelques images à la fin.

Ce n'est pas ce qu'on opère. On opère des cas catastrophiques. D'accord ? Donc anesthésie locale, c'est bon.

Donc toute lésion suspecte de malignité, il faut faire une biopsie avec une étude anatomopathologique qui permet de faire le diagnostic de certitude. Pour l'imagerie, c'est quoi l'intérêt de l'imagerie ? C'est essentiellement l'extension. C'est un bilan d'extension, ce n'est pas un bilan diagnostique.

Le diagnostic, on l'a par l'anapath. Donc l'extension peut être locorégionale ou bien à distance. Pour la locorégionale, c'est l'orthopantomogramme.

C'est le terme scientifique de la panoramique dentaire. On n'acquiesce pas panoramique, orthopantomogramme. Panoramique pour la mienne.

Donc cet orthopantomogramme permettra d'apprécier l'état dentaire et de voir essentiellement l'extension osseuse. On peut avoir des images lithiques mal limitées, on peut avoir une rupture de corticale ou bien des dents refoulées extrusées. Extrusée, c'est-à-dire qu'on va trouver des dents qui sont suspendues.

Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image panoramique pour montrer ça. C'est un orthopantomogramme qui est normal sans lésion. Après, on a l'échographie cervicale.

On la demande rarement. C'est surtout pour les adénopathies. Actuellement, l'examen qu'on utilise le plus souvent, c'est la TDM.

La TDM cervicofaciale qui permet d'analyser la matrice tumorale, de préciser essentiellement l'extension osseuse, de préciser les adénopathies, rechercher une deuxième localisation et permet de guider la stratégie thérapeutique. Pour l'IRM, c'est surtout l'extension au parti mou. Deuxième chose pour l'IRM, c'est qu'elle permet d'analyser une récurrence, c'est-à-dire si on a un patient avec une tumeur qui est récurrente, on ne demande pas la TDM, on demande l'IRM parce que l'IRM permet de faire la part entre ce qui est tumorale et ce qui est inflammatoire.

Et puis, bien sûr, les adénopathies. L'examen clé, c'est la TDM, surtout pour l'extension osseuse. Et le deuxième examen, c'est l'IRM, surtout pour l'extension des parties molles.

Par exemple, si on a une tumeur qui siège au niveau de la langue, au niveau du plancher, quel est l'examen le plus probable ? L'IRM ou la TDM ? L'IRM, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'extension soit vers la langue, soit vers le plancher. Si on a une lésion, par exemple, qui siège au niveau de la gencive mandibulaire, qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? C'est l'extension osseuse. Donc, je vais demander une TDM.

Pour l'extension à distance, c'est la radiothoraxie, l'échographie abdominale. Actuellement, c'est la TDM thoraco-abdominopelvienne. Quand on demande la TDM, par exemple, faciale, on

demande en même temps de réaliser une TDM thoraco-abdominopelvienne à la recherche de métastase.

Le PET-SCAN, il n'est pas bien sûr toujours accessible, mais il permet de préciser une tumeur primitive si on a une adénopathie isolée, une seconde localisation et permet la surveillance aussi bien du traitement ou en cas de récurrence. L'endoscopie, elle est toujours indiquée à la recherche d'une deuxième localisation, surtout la panendoscopie. La fibro-eugastro-diœdœnale, gœnœralement, on ne la demande pas, mais certains auteurs la recommandent.

Ce bilan clinique et paraclinique permettra de faire un bilan d'extension en prœcisant la taille de la tumeur, l'extension musculaire, osseuse et vasculaire. Il va prœciser l'extension ganglionnaire et puis l'atteinte à distance, ce qui permettra de classer les tumeurs en fonction de la classification TNM. Vous connaissez les classifications TNM.

La classification TNM est une classification qui a un intœrœt essentiellement pronostique, mais aussi thœrapeutique. La huitiœme œdition, c'est la derniœre classification, parce qu'au dœbut ils classaient les tumeurs en fonction plutœt de la taille. Actuellement, ils classent les tumeurs aussi bien en fonction de la taille qu'en fonction de l'infiltration.

Plus l'infiltration est profonde, plus la tumeur est de mauvais pronostic. Ils classent bien sœr les tumeurs en T, de Tx jusqu'à T4. Le T4, gœnœralement, ce qu'on voit sur le service, c'est le T4.

T1, c'est rare. T4, c'est des tumeurs gœnœralement qui sont avancœs ou trœs avancœs. Puis on a les adœnopathies.

Les adœnopathies descendent en fonction de la taille et de l'unilatœralitœ ou bien la bilatœralitœ. Et puis les mœtastases, bien sœr, absence de mœtastases, mœtastases à distance, ou bien les mœtastases ne sont pas œvaluœs. C'est bon jusqu'à maintenant ? Bien, on continue.

Comme on a vu tout à l'heure, les cancers de la cavitœ buccale peuvent siœger en plusieurs œmes. Les formes les plus importantes, c'est les formes topographiques plus que les formes histologiques. Donc on va commencer par les formes topographiques.

La premiœre forme, c'est les cancers de la langue qui sont les plus frœquents. Ils sont localisœs le plus souvent au niveau de la langue mobile et le plus souvent au niveau du bord latœral, qu'on appelle aussi marginal. La pointe est rare.

Il faut savoir que les tumeurs, quand on a une tumeur qui est un petit peu latœralisœe, gœnœralement les adœnopathies sont latœralisœes. Par exemple, si on a une tumeur à droite, le drainage lymphatique va se faire du cœtœ droit. Gauche, le drainage lymphatique du cœtœ gauche.

Mais si on a du tumeur mœdien, le drainage lymphatique se fait de faœon bilatœrale. Donc chaque fois qu'on a une tumeur au niveau de la ligne mœdienne, c'est-œ-dire au niveau de la lœvre au centre de la lœvre, au niveau de la langue au milieu, au niveau du plancher au milieu,

généralement il faut rechercher les adénopathies de façon bilatérale. Donc la face ventrale, généralement rarement, mais on a une extension au niveau du planche.

Sur le plan clinique, on aura une douleur. On aura une limitation des différents mouvements de la langue. Généralement, quand le patient sort sa langue, on a une déviation de la langue du côté atteint parce qu'il compense un petit peu la douleur.

Quand tu lui demandes de sortir la langue, généralement il cherche la langue à gauche, quand il cherche la langue à droite, il sort sa langue du côté droit. Sur le plan macroscopique, comme on a vu tout à l'heure, ce soit une ulcération, un bourgeon exophytique reposant sur une base qui est indurée. Ce sont des cancers qui sont très lymphophiles.

L'extension au niveau des adénopathies est presque toujours là. Donc généralement, on réalise des curages systématiquement, même si on n'a pas d'adénopathie clinique. Le deuxième cancer de la cavité buccale, c'est le cancer du plancher buccal.

On a les formes ulcérées infiltrantes. Parfois, on peut avoir des fissures au niveau du plancher. Le siège le plus fréquent, c'est essentiellement au niveau du plancher antérieur.

Parfois, ils sont diagnostiqués à tort comme des lithiases salivaires. Des fois, le patient vient, on examine, on trouve une petite ulcération en regard de l'orifice de Vartan. Vous connaissez l'orifice de Vartan? Non? Dans la glande submandibulaire, elle draine sa salive par un petit orifice sous la langue.

C'est comme deux petits orifices. C'est l'orifice de Vartan. Des fois, on a une ulcération en regard, alors que c'est une tumeur.

On dit au patient, non, c'est rien du tout, elle a un petit lithiase et avec le temps, il revient avec un cancer qui est très étendu. Donc, il faut faire attention. Si on a n'importe quelle inflammation au niveau buccal, soit biopsier, soit surveiller à la limite.

Le plancher latéral et postérieur, l'atteinte du plancher postérieur est la plus grave parce qu'elle s'étend généralement vers les muscles masticateurs. On a les muscles pterygoïdiens internes, ce qui va entraîner une limitation à l'ouverture buccale, une limitation à la protraction de la langue. On aura une gêne à la déglutition, le patient aura une dysarthrie et il aura un trismus à 100%.

Vous connaissez le trismus ? L'extension se fait vers la mandibule et vers la langue et c'est un cancer aussi très lymphophilique. Les cancers de la langue siègent le plus souvent au niveau du vermillant de la lèvre inférieure, vu que la lèvre inférieure est plus exposée au soleil que la lèvre supérieure. On a une dégénérescence d'une cérite actinique le plus souvent.

L'aspect ulcéro-bourgeon est fréquent. La lésion, c'est une lésion qui est généralement visible et qui normalement doit être traitée précocement. Mais généralement, on voit des patients pires que

ça, une lésion accessible.

C'est ce que j'ai deux ans après avec une lèvre détruite et c'est des patients, quelle qualité de vie auront après ? Quand tu vas enlever toute une lèvre du patient. L'atteinte peut intéresser également la commissure labiale et en cas d'atteinte de la commissure labiale, ce sont des tumeurs qui sont un petit peu plus graves que la lèvre. Les cancers de la face interne de la joue, on peut avoir la forme bourgeonnante qui est la plus fréquente, mais parfois on peut avoir une dysplasie sur un lichen.

Par exemple, ce qu'on voit sur cette image, on voit deux petites ulcérations sur un lichen, un lichen blanc. On voit de la blancheur qu'on voit. Donc on se sent des cancers de mauvais pronostics.

L'extension est rapide au niveau de la face interne de joue et se fait essentiellement vers les muscles de la joue. Par la suite, qu'est-ce qu'on a en plus sur la joue ? On a le passage du nerf facial, le passage du canal de Steynan et on a la boule de bichon. Vous connaissez la boule de bichon ? Vous connaissez la boule de bichon ? La boule de bichon qui garde la forme de la joue.

Vous avez entendu parler de la bichectomie ? Quand on veut amincir les joues, c'est une intervention à la mode. Donc on enlève la boule de bichon qui garde la forme des joues, surtout latéralement. La boule de bichon s'étend en haut vers la fosse pterygoïdienne.

Et si on a une atteinte de la boule de bichon, on aura systématiquement une atteinte de la base du crâne parce que la tumeur achète la boule de bichon et elle va s'étendre vers la fosse pterygoïdienne. La fosse pterygoïdienne est en rapport avec la base du crâne. Donc ce sont des cancers de très mauvais pronostics.

Après, on a les cancers du trigone rétro-molaire. Le trigone rétro-molaire, comme je vous l'ai dit, c'est la partie postérieure. Normalement, on l'appelle trigone rétro-molaire ou commissure intermaxillaire.

Généralement, ce sont les dernières molaires. Leur pronostic est très mauvais. Leur diagnostic est difficile parce que c'est une lésion qui n'est pas toujours accessible.

Le patient qui a un peu de douleur, un peu de gêne, il se dit généralement, alors que normalement, c'est une lésion. Ce sont des lésions qui s'étendent rapidement vers les muscles masticateurs et vers la base du crâne. Généralement, on a un envahissement osseux qui est précoce, des algues mandibulaires, des autalgies réflexes, un trismus et une dysphagie.

L'extension loco-régionale est très rapide et ce sont des cancers, comme je l'ai dit, qui sont de très mauvais pronostics. Vous voyez sur l'image, c'est ça, c'est le trigone rétro-molaire. Généralement, c'est une lésion qui ne guérit pas.

Il faut savoir que si un patient vous rapporte n'importe quelle lésion qui ne guérit pas, il faut

suspecter un cancer. Peu importe. Lésion qui dure pendant un mois ou un mois et demi, c'est un cancer.

Pas photo, d'accord ? Ça ne va pas guérir. Après, on a le cancer des gencives. Essentiellement, on a la gencive inférieure, mais on peut avoir une atteinte de la gencive supérieure aussi.

C'est des lésions ulcéro-bourgeonnantes avec mobilité dentaire et chute précoce. Ils peuvent être diagnostiqués à tort comme une parodontite. On a une infiltration osseuse précoce, vu que la gencive est attachée à ce niveau.

On peut avoir un envahissement d'une R5-3 qui est un facteur de mauvais pronostics de ces cancers. Par la suite, on a le cancer du palais. Le cancer du palais, généralement, ce sont des tumeurs glandulaires.

La forme peut être évoluée avec extension au niveau du maxillaire, au niveau du sinus maxillaire, au niveau des fosses nasales. Mais aussi, on peut avoir des fois des tumeurs qui arrivent jusqu'au contact du globe oculaire. Parfois, on enlève l'ouïe de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil, l'œil de l'œil.

C'est malheureux. Surtout après le Covid. Le Covid, on a vu qu'il n'y avait pas de déplacement et tout ça.

On a eu des patients catastrophiques. Il n'y avait pas de prise en charge de patients. Donc, on n'a eu que des cas historiques.

Après les formes topographiques, on passe aux formes histologiques. C'est les différents types histologiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a le carcinome On a les lymphomes et les autres, puis on a les formes évoluées.

Généralement, ce sont des formes qu'on appelle cellulitiques, c'est-à-dire qu'elles sont des formes infectées, qui génèrent une odeur fétide. On a une extension très importante avec un retentissement général important. Le patient a une cachexie sévère parce qu'une fois que tu as une lésion buccale qui va bloquer toute l'alimentation, tu ne t'alimentes plus.

Il y en a qui craquent les liquides, ou là ils ne mangent même pas, il y en a qui se lavent les mains, ou souvent on a ça. Un patient de 2 mois, 3 mois, il ne boit que de l'eau, donc généralement il vient dans un état cachexique sévère. Leur prise en charge est lourde et il se sent des tumeurs de mauvais pronostics.

Puis on a les formes selon le terrain, surtout la forme de l'enfant, et le plus souvent ce sont des sarcomes chez l'enfant. Le diagnostic différentiel, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout on a l'ulcération traumatique, soit par morsure ou autre. On a l'ulcération tuberculeuse, syphilitique, on a l'arthrogène, l'actinomyose chronique, ou l'héperodontopathie chronique.

Mais gardez à l'esprit qu'en moindre doute, il faut réaliser une biopsie avec étude anatomopathologique. D'accord ? Question d'exemple. Ok.

Donc, on a fait le diagnostic clinique, on a fait le diagnostic paraclinique, on a fait le diagnostic d'extension, on va voir si on pourra opérer notre patient ou non. Pour le faire, il faut demander bien sûr un bilan préthérapeutique. Ce bilan préthérapeutique aura pour objectif essentiellement de préciser les différentes parts du patient.

Est-ce qu'il est cardiaque, est-ce qu'il n'est pas cardiaque, ou autre. Préciser son bilan nutritionnel. Pourquoi le bilan nutritionnel ? Parce qu'il faut savoir que le patient va subir une intervention, et il faut voir est-ce que ce patient va supporter cette intervention ou non, parce que si il a une maladie, pour le tuer, il vaut mieux le laisser tranquille.

Ce bilan SANGA comportera un bilan hépatique, rénal, cardiorespiratoire, une consultation préanesthésique pour que le réanimateur décide est-ce qu'on pourra l'opérer ou non. Le bilan dentaire est systématique. Il faut éradiquer les foyers infectieux, il faut mettre en état les dents et utiliser des gouttières fluorées.

Pourquoi le bilan dentaire est très important dans les cancers de la cavité buccale ? Parce que généralement dans la prise en charge de ces cancers, on aura besoin de radiothérapie dans 90% des post-opératoires, parce que c'est des lésions le plus souvent très évoluées. Et si on utilise de la radiothérapie, on a souvent le risque d'ostéoradionécrose, c'est-à-dire nécrose de l'os, surtout mandibulaire ou maxillaire. Et parmi les facteurs qui favorisent l'ostéoradionécrose, c'est le mauvais état buccodentaire.

Avant de traiter le patient, des fois, en préopératoire, il y a un mauvais état buccodentaire pour ne pas avoir des ostéoradionécroses qui sont très difficiles à traiter. Et puis on passera au traitement. Le but du traitement, c'est d'abord l'ablation carcinologique de la tumeur.

Il faut rétablir la fonction et restituer la morphologie, mais ce n'est pas toujours facile, et bien sûr de prévenir les complications. Pour le principe du traitement, c'est un traitement qui est multidisciplinaire. Ce n'est pas le maxi ou le bado qui prend en charge ces patients.

Il y a l'ORL, il y a le réanimateur, il y a le nutritionniste, il y a l'orthophoniste et surtout il y a l'oncologue. Donc généralement, la décision de prise en charge de ces patients est décidée dans ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire pour décider qu'est-ce qui est mieux pour le patient, est-ce qu'on va l'opérer, est-ce qu'on va utiliser une radiothérapie chimio ou bien le laisser tranquille. Le malade doit être informé et on doit avoir son consentement éclairé parce que c'est des prises en charge qui sont vraiment très lourdes.

Ce qu'on fait, c'est qu'on ne montre pas d'image de ce qu'on va faire parce que si on montre l'image de ce qu'on va faire, le patient ne va pas être opéré. D'accord ? Généralement, on accepte ça. Les moyens.

Sujet triste. Mais bon, les moyens, d'abord on a le traitement préventif, c'est l'arrêt du tabac et de l'alcool, le dépistage et surveillance ainsi que le traitement de toutes les lésions précancéreuses, la vaccination contre l'HPV, ce qu'on vient d'instaurer au Maroc et la mise en état buccodentaire. Le traitement médical, c'est les antalgiques, palier 1 ou palier 2 en fonction de l'importance de la douleur.

Ce sont généralement des tumeurs qui sont très douloureuses, les patients qui portent la douleur, parce qu'ils sont à proximité d'un air. Une atteinte d'un air mandibulaire, d'un air mentonnier ou d'un air facial va entraîner une douleur atroce. Les antibiotiques à large spectre pour les formes célibatiques, les soins de bouche, le brossage, le traitement de la dénutrition, ce traitement qui va à la supplémentation, les voies parentérales, jusqu'à des fois on est obligé de sonder le patient, si le patient ne mange plus, de donner un sondage afin de l'alimenter pour l'améliorer.

Des fois on garde le patient un mois au service avec nos clous, nos olives flaccantes, afin qu'on puisse l'opérer. Pour le traitement chirurgical, anesthésie et l'intubation, soit local ou général, le plus souvent c'est une anesthésie générale. Donc ça va dépendre bien sûr du type de l'intervention, de l'étendue de la tumeur, de la nécessité ou non de réaliser un curage ganglionnaire.

Vous savez ce que c'est qu'un curage ganglionnaire ? Oui et non ? Évidemment ganglionnaire. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Le curage ganglionnaire, on va en parler après, c'est le fait qu'on enlève les adénopathies. Donc l'état général du patient.

L'intubation le plus souvent est nasotraquiale, c'est-à-dire qu'on passe la sonde par le nez jusqu'au niveau de la trachée. Il y a aussi l'orotraquiale, on ne peut pas l'utiliser vu que c'est du tumeur endo-buccal, ou bien la trachyotomie, c'est-à-dire qu'elle a une tumeur très importante et que le réanimateur n'arrive pas à introduire la sonde au niveau de la nasotraquiale. Pour la tumeur, l'exérèse doit être large, en monobloc, avec des marges de sécurité.

Les marges de sécurité, c'est ce qui est tracé en rouge, je ne sais pas si vous le voyez ou non, c'est les petits pointillés ici. Les marges de sécurité, on met de combien de millimètres on va s'éloigner de la tumeur. Ils sont comptés à partir de l'induration.

C'est ce qu'on voit. Ce n'est pas l'aspect, mais plutôt de l'induration. On palpe la tumeur et on réalise nos marges d'exérèse en fonction de l'induration.

Généralement, les marges d'exérèse d'un carcinome épidermoïde entre 0,6 et 10 mm, nous, c'est généralement 10 mm, 1 cm. Dans la majorité des cas. Parce que le problème qu'on a, c'est quand on envoie la lésion à un anatomopathologiste, on a une rétraction des tissus.

Parfois, quand on est à 1 cm, ça veut dire que vous êtes à 0,5, donc on n'est pas vraiment carcinologique. La technique, soit la technique classique, c'est-à-dire qu'on enlève la tumeur, ou

bien par chirurgie micrographique de MOSS, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la chirurgie micrographique de MOSS, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on enlève un centimètre, on enlève environ 2 mm. C'est-à-dire que l'exérèse, c'est-à-dire que l'extempore, c'est-à-dire qu'on a une tumeur, c'est-à-dire qu'on enlève 2 mm, c'est-à-dire que l'extempore, c'est-à-dire qu'on a une tumeur, c'est-à-dire 2 mm, pour être sûr qu'ils sont dans les marges carcinologiques.

D'accord ? Nous, non, on ne fait pas ça parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, deux principes, on enlève toujours un centimètre. La pièce doit être toujours orientée, comme ce que vous voyez dans le schéma.

Donc, normalement, on trace un schéma. Mais bon, on trace un schéma. Ce qu'on ne peut pas enlever, normalement, tout ce qu'il enlève, il le fixe comme un plan.

Comme un plan, car ce mot fait la tumeur, les structures. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une mandibule, on a un plancher ici, on a une langue. Donc, c'est une tumeur qui est étendue de la langue, s'étend sur le plancher et arrive jusqu'au trigone rétro-molaire.

Vous voyez ? D'accord ? Donc, normalement, il la fixe. Pour les anatomes pathologistes, je vois qu'ils ont vraiment l'orientation, parce que l'anatome pathologiste, c'est celui qui est orienté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un schéma.

Donc, il y a des fils. Par exemple, je mets, par exemple, ici, je mets un fil. Le fil est du côté lingual.

Par exemple, ici, par exemple, le trigone rétro-molaire, je mets deux fils. Donc, les deux fils, ils sont du côté du trigone rétro-molaire et ainsi de suite. Et ça, vous allez voir, il y a des petites bandes, des petits prélèvements.

C'est ce qu'on appelle des recoupes. Ça veut dire quoi, des recoupes ? C'est-à-dire qu'on enlève la tumeur. On a un petit doute.

On n'est pas un centimètre sûr. Donc, on a une petite bande qu'on sert à l'anatome pathologiste. Ça, c'est pour l'information.

Ce n'est pas très important à retenir. Donc, la pièce doit être orientée. Pour les voies d'abord et le type d'intervention, il dépend, bien sûr, de la localisation de la tumeur.

La chirurgie, les avantages de la chirurgie, c'est qu'elle permet un contrôle carcinologique de la tumeur. C'est-à-dire qu'on enlève la tumeur et on a des marges de sécurité sûres quand ça tombe dans l'anatome pathologiste et il nous répond qu'on est bien ou non. Et il permet de classer la tumeur dans un but pronostic essentiel.

Ses inconvénients, c'est que, bien sûr, elle peut être très mutilante avec un risque de

complications qui peuvent être des fois dramatiques. Pour les adénopathies, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le curage ganglionnaire cervical. Donc, le curage, c'est qu'on enlève le tissu.

Les adénopathies, on n'enlève pas les adénopathies on enlève le tissu cellulo-grassey du cou. Le tissu cellulo-grassey. Tout ce qui est cellulo-grassey, on l'enlève.

Et à l'intérieur de ce tissu, parce que des fois, les adénopathies, elles sont micrométriques. Vraiment, c'est des petits points. On ne les voit même pas.

Sauf s'ils sont atteints. Soit ils sont inflammatoires, réactionnaires, soit ils peuvent même être tumoraux. Là, on les voit.

Donc, le curage, il y a trois types de curage. Il y a le curage fonctionnel. C'est ce qu'on utilise le plus souvent.

C'est-à-dire qu'on enlève la chaîne sous-mentonnière, la chaîne submandibulaire. Les chaînes que vous avez vues tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne sous-mentonnière, c'est le 1. La chaîne submandibulaire, c'est le 2. Et la chaîne jugulocarotidienne et spinale, c'est le 3 et le 4. En conservant le muscle sternocléidomastoïdien, la veine jugulaire interne et le nerf spinal.

Et il y a le curage fonctionnel, c'est sur l'image. Ça, c'est le muscle sternocléidomastoïdien. D'accord ? Là, on a la veine jugulaire.

Et ici, c'est le spinal. C'est le nerf spinal. Et dans ce curage, on conserve ces structures.

Après, on a le curage radical. C'est le fonctionnel, mais sans conserver des structures. Ce que vous voyez ici.

Généralement, ce curage, on l'utilise si on ouvre et qu'on trouve des lymphatiques qui sont collées sur la jugulaire ou sur le muscle sternocléidomastoïdien ou là, sur le spinal. Le radical. Et puis, qu'est le sélectif ? Le sélectif, on enlève que les trois groupes.

Un, deux et trois. S'il nous répond qu'il n'y a pas d'adénopathie, on arrête. S'il répond qu'en quoi il y a des adénopathies tumorales, on continue notre curage.

Donc, le curage, il peut être uni ou bilatéral en fonction de l'atteinte. Ce qu'il disait tout à l'heure, si l'atteinte est médiane, c'est bilatéral systématique. Si l'atteinte est unilatérale, elle est latéralisée gauche ou droite, c'est unilatéral.

Il faut savoir que, normalement, le curage, c'est un stress de plus pour le patient parce que c'est une intervention de plus. Le curage, il prend un côté, ça prend presque une heure et demie. Il y a un curage complet, ça peut prendre jusqu'à trois heures de gestes.

Parce que quand on veut opérer un patient, on commence toujours par le curage. On a trois heures. Donc, c'est un stress de plus.

Mais malheureusement, il n'y a pas de moyen à part le curage pour savoir le statut histologique des adénopathies. Le seul moyen qui existe, c'est le ganglion sentinelle. Je pense que vous avez déjà entendu parler du ganglion sentinelle.

Oui ou non ? Oui. Parce que le ganglion sentinelle, le groupe 1, tu n'as pas besoin d'enlever tout ça, de faire ni un curage fonctionnel ni un curage radical. Ou c'est 15-20 minutes, tu as enlevé ce mot, c'est un adénopathe, tu attends de la réponse, ou c'est rien.

Malheureusement, le ganglion sentinelle n'est pas faisable dans notre contexte. Alors qu'on a reçu un produit qu'on injecte et une machine qu'on oriente qui nous montre qu'il n'y a pas d'adénopathie. Oui.

Parce qu'on n'a pas le matériel et parce qu'on n'a pas de volonté malheureusement. C'est la même chose. Parce qu'ils disent que c'est la médecine nucléaire.

Parce qu'ils n'ont pas les produits. La médecine nucléaire, pour leur demander de faire ça, ils injectent le produit, pour détecter le ganglion. Ils disent non, c'est le ganglion.

A l'étranger, les chirurgiens le font. Ils ont le matériel, ils l'injectent, ils le bloquent, ils disent non, c'est la machine nucléaire. Et ça coûte beaucoup d'argent.

D'accord. Après, bien sûr, quand on va faire l'exercice tumoral, on aura une perte de substance, soit mycose, putalée, osseuse, en fonction de l'étendue de la tumeur. Cette perte de substance doit être traitée en fonction de l'importance et de sa localisation.

On a différents moyens, soit la cicatrisation dirigée. Qu'est-ce que c'est que la cicatrisation dirigée? On ne fait rien. On le suive, les pomades, le pansement, il commence à cicatriser.

Par exemple, une petite lésion face à un terme de jour, on peut la laisser en cicatrisation dirigée. Soit les sutures simples, si c'est auto-ferment, si on arrive à fermer, il y a les sutures simples. On a les greffes.

C'est quoi les greffes? Les greffes, on prend de la peau. Il y a quelque chose qui est de la couche superficielle de la peau. Généralement, les prélèvements sont sur l'esclavicleur, face à un terme du bras, face à un terme de la cuisse, à la sangle étendue, qui est donc l'épiderme.

D'accord? Et on le fixe, avec la perte de substance. Soit les plasties locales, c'est-à-dire qu'on mobilise les structures adjacentes. Soit on a les lombos.

Les lombos, on mobilise plus de structures. Par exemple, en endobuccal, généralement, le lombo qu'on utilise le plus, c'est le grand pectoral. Quand on enlève une moitié de langue, un plancher, qu'on met dans une palette cutanée, avec le muscle grand pectoral, on le prélève, on la retourne, et on la met à la place de la langue et du plancher.

D'accord? On a aussi les lombos vascularisés, c'est-à-dire qu'on a gardé le lombo sur ses artères et ses veines. On a aussi les lombos micro-anastomosées, c'est-à-dire qu'en mettant le gelé, par exemple, si on a une perte de substance du plancher plus la mandibule, comme chez la face externe de la jambe, on prélève une palette cutanée avec de l'os, avec le péroné, une partie du péroné. Et on branche l'artère et la veine au niveau du cou, avec une autre artère, par exemple, avec l'artère faciale et la veine faciale, pour avoir une nutrition pour notre langue.

D'accord? Donc il y a deux lombos, soit pédiculés, soit micro-anastomosés. Puis la réhabilitation prothétique, bien sûr, afin d'avoir des prothèses et permettre aux patients de manger. Les autres techniques, à part la chirurgie, qui est le laser, CO2, le laser qu'on utilise pour les cicatrices, mais aussi pour les ablations.

Il y a la cryothérapie. Qui sait ce que c'est que la cryothérapie? Pardon? Par l'azote. L'azote, parce que, normalement, on est très froid.

D'accord? C'est par le froid. Donc, on brûle les lésions par le froid. Soit la photothérapie dynamique.

La photothérapie dynamique, qu'est-ce que c'est? Dermato, je pense. La photothérapie dynamique, c'est qu'on injecte un produit photosensibilisant au niveau de la lésion. Après, on expose la lésion à une source lumineuse.

Elle brûle la lésion. Le problème et l'inconvénient de ces techniques, c'est qu'on n'a pas de preuves histologiques. On ne sait pas si on a effectivement détruit la lésion ou non.

Ce n'est pas comme la chirurgie. La chirurgie, tu es sûr que tu as brûlé la lésion à un centimètre de marge, alors que ces techniques te donnent le doute. Tu enlèves et tu te dis que tu n'as pas brûlé la lésion.

D'accord? La chirurgie reste toujours de mise. Si tu as une petite lésion, une petite leucoplasie, on voit surtout plusieurs auteurs qui voulaient t'aider pour les lésions préconcrètes, de préférence. Mais si tu as un T1, une petite lésion sous adénopathie qui n'est pas très étendue, tu peux utiliser le laser ou la cryothérapie, mais non, on n'utilise pas.

Après, on a la radiothérapie. Elle peut être exclusive ou en association à la chimiothérapie et ou à la chirurgie. Elle peut être adjuvante ou non adjuvante.

On a la radiothérapie externe qui est classique. Il y a les nouvelles techniques de l'IMRT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IMRT.

Des informations pour vous, ça fait l'IMRT, c'est parce que le problème c'est la radiothérapie externe. C'est quoi le problème avec la radiothérapie externe? La radiothérapie externe, le problème c'est que, par exemple, un cancer prostatique, la radiothérapie externe, je ne touche

pas que la prostate et je détruis toutes les structures aux alentours. L'IMRT permet de cibler mieux.

Il touche un petit peu. Il cible mieux et il touche un tout petit peu les structures adjacentes. Le meilleur qui ne touche pas les structures adjacentes, il y a la curithérapie.

La curithérapie, c'est quoi? C'est un lard. On met un fil d'iridium à l'intérieur de la prostate, par exemple, ou à l'intérieur de la lèvre et on fixe la source de radiothérapie et on la fait courir. De un, ça permet, parce que la radiothérapie, pour que tu saches, quand on dit, par exemple, qu'il y a 10 ressources de la radiothérapie, pourquoi 10 ressources? Parce qu'il faut atteindre un niveau.

Mais il ne peut pas, dès le premier jour, atteindre 70 degrés, par exemple, comme ici. Il peut atteindre 15 degrés, un peu plus, 20, 30, parce qu'atteindre 70, c'est un mois, d'accord? C'est une séance. Alors que la curithérapie, quand on dit 60 degrés, c'est ça.

Il branche les fils pour qu'il atteigne 60 degrés. C'est mieux. Le problème, c'est que ça coûte trop cher, surtout dans notre contexte.

C'est les fils, d'accord? Il y a des fils d'iridium à l'intérieur de la lèvre. Pourquoi vous croyez à la source de la radiothérapie? Donc, la radiothérapie, la classique ou la nouvelle, elle peut être exclusive ou bien en post-opératoire. C'est sur la tumeur et aussi bien sur les aires ganglionnaires si on a une atteinte ganglionnaire.

La curithérapie, les fils d'iridium, selon l'association, elle est contre-indiquée en cas de contact os. Si la lésion arrive au niveau de l'os, elle est contre-indiquée. La chimiothérapie, il n'y a pas vraiment d'efficacité prouvée en termes de survie.

Elle peut être néoadjuvante, surtout à but palliatif. On a la toxicité hématologique, hépatique, alopécie et reste. Elle est surtout indiquée pour l'enfant.

Les thérapies ciblées, elles bloquent la croissance tumorale, même si il y a de nouvelles études, comme les molécules cetuximab et le reste. Il faut garder à l'esprit que le gold standard dans le traitement des cancers de la cavité buccale reste la chirurgie, la chirurgie, la chirurgie. Déjà la chirurgie, peut-être qu'un radiothérapeute peut vous dire que la radiothérapie, non, mais les cancers de la cavité buccale.

La prostate, ce n'est pas chirurgical toujours. D'accord ? Le résultat de la radiothérapie, peut-être meilleur, parce que la chirurgie entraîne plusieurs complications. Alors que la radiothérapie, en termes de prostate, elle est meilleure.

En termes de cavité buccale, non. Il n'y a pas mieux que la chirurgie parce que c'est une odeur fétide, parce que c'est une gêne pour le patient. Il y a beaucoup de choses.

Pour l'indication, elle se discute toujours en RCP, avec tous les intervenants. En cas de tumeur

résécable, patient opérable, T1 ou T2, c'est la chirurgie ou la curie-thérapie. Curage bilatéral, c'est le tumeur médian.

La radiothérapie, si les marges sont tumorales. Ici, l'anatome pathologiste, cefnalie et la lésion, ou cefnalie et la galinara, vous êtes encore tumorale. Soit on peut utiliser la radiothérapie, mais de préférence la chirurgie.

Si on n'a pas fait de reconstruction importante, mais des fois, on a déjà fait la reconstruction, quand on fait la reconstruction, on modifie les tissus, on mobilise les tissus. Quand on mobilise, on ne peut pas faire de reprise chirurgicale. Là, on est obligé de faire une radiothérapie.

Pour le T3, T4, c'est chirurgie large et radiothérapie post-opératoire, chimiothérapie néoadjuvante, curage et radiothérapie post-opératoire, ou bien radiothérapie, chimiothérapie concomitant. Si la tumeur n'est pas résécable, le patient n'est pas opérable ou refuse la chirurgie, c'est la radiothérapie externe exclusive, c'est des moyens palliatifs à la limite, la chimiothérapie néoadjuvante, plus réévaluation, ou bien radiothérapie concomitante. Pour les métastases, c'est la chimiothérapie, ou bien les essais cliniques, quoi qu'il n'y a pas vraiment de preuves.

Pour la surveillance, donc la surveillance, elle doit être régulière, et prolongée, et les cliniques, radiologiques et biologiques. Pour le rythme, la première année, c'est un contrôle clinique tous les deux mois, il faut revoir votre patient tous les deux mois, puis la deuxième année, tous les trois mois, tous les quatre mois pendant la troisième année, et puis tous les six mois pendant la quatrième et la cinquième année. Il faut revoir le patient une fois par an, pendant toute sa vie et votre vie.

Pour les complications, donc les complications, il peut s'agir de complications, bien sûr, en rapport avec la chirurgie, en rapport avec la radiothérapie ou avec la chimiothérapie. Donc ces complications, elles peuvent être à court terme, à court terme, par exemple, l'hématome, il faut prévenir bien sûr par une bonne hémostase, des sutures et tout ça, l'infection prévenue par des antibiotiques, on peut avoir des détresses respiratoires, il faut bien ménager les voies aériennes digestives, par exemple, si on va faire une reconstruction très importante, il faut prévoir une trachytone. Le malade, il est intubable, par exemple, par voie endobucale, et si on prévoit qu'on va remplir sa bouche, c'est une trachytomie parce que sinon, il ne pourra pas respirer par la suite.

On a les fistules et les orostomes. Orostomes, vous connaissez ? Fistules, vous connaissez ? C'est quoi, fistules ? Entre l'ésion et l'extérieur à travers la peau. L'orostome, c'est une communication entre la cavité buccale et le cou.

D'accord ? Quand on enlève, par exemple, un plancher, il n'y a plus rien qui s'interpose entre la cavité buccale et entre le cou. D'accord ? Et de ce fait, on aura un passage de la salive au niveau du cou. Le problème, l'équigrocalien, c'est que cette salive, elle risque d'éroser les gros vaisseaux.

Elle va détruire petit à petit la paroi de la carotide et de la veine jugulaire. Le patient, il va décéder par rupture d'un vaisseau. Il faut toujours, notre antiseptique quand on en perd ses patients, c'est de bien fermer la communication entre la bouche et le cou.

D'accord ? On a l'incontinence labiale, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à contenir sa bouche. Il bave tout le temps. La salive du bas des élèves font moins.

Surtout, quand on enlève la sangle musculaire et l'orbiculaire des lèvres, le patient, il n'arrivera plus à contenir sa salive. Un liquide oui ou non. L'incontinence, la mycrostomie, c'est quoi la mycrostomie ? C'est une petite bouche.

Quand on a, par exemple, une tumeur de la moitié de la lèvre, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève la moitié de la lèvre, de la lèvre supérieure, par exemple, et on la retourne. Il y en a à la place de la lèvre caméra, de la lèvre caméra, qu'il y a dans notre lèvre et dans notre lèvre. Donc là, il y aura une petite bouche.

Normalement, ces patients, on les reprend par la suite pour ouvrir un petit peu, mais il n'aura jamais la bouche légatoine initiale. Il y aura toujours une mycrostome. La radiomycide, radiothermie, c'est les complications de la radiothérapie.

Vous connaissez ? L'alopécie, c'est connu. Donc, les complications à long terme, c'est l'ostéoradionécrose prévenue par quoi ? Par le bon état du côté dentaire. Donc, il faut traiter tous les foyers infectieux du côté dentaire quitte à enlever toutes les dents.

Donc, on enlève le tout même sans avoir son consentement d'être parce qu'on aura une ostéoradionécrose et une fois, on a perdu un patient à cause d'une ostéoradionécrose. Il est décédé pour le service à cause d'une ostéoradionécrose. À long terme, on peut avoir bien sûr des récidives locales comme complications.

On peut avoir une récidive ganglionnaire ou à distance. Pour le pronostic, la survie globale à 5 ans est de l'ordre de 44 jusqu'à 68, mais ce n'est pas toujours vrai. Les facteurs de mauvais pronostic, il y a des facteurs cliniques, c'est-à-dire si on a un stade avancé T3 ou T4, c'est un mauvais pronostic.

On peut avoir des adénopathies multiples et volumineuses parce que généralement, on n'a pas d'adénopathie. Des fois, on a des adénopathies radiologiques, mais on n'a pas de clé masculine. Mais l'extension est parfois... Il y a peu d'extensions lymphatiques.

D'accord ? Si on a des adénopathies volumineuses, c'est un mauvais pronostic. Un envahissement osseux, une tumeur non résécable, des métastases à distance ou bien un état général qui est altéré avec des comorbidités associées. Les facteurs histologiques de mauvais pronostic, essentiellement, c'est les marges chirurgicales envahies ou insuffisantes, c'est-à-dire

quand on enlève dans le temps pathologique la tumeur, c'est un mauvais pronostic, le carcinome peu différencié, la présence d'emballes vasculaires et ou d'engainements perinerveux et la rupture capsulaire dans les adénopathies.

Quand on enlève le curage, il y a une rupture capsulaire dans les adénopathies, c'est un facteur de mauvais pronostic. Quelques cas, un facteur de mauvais pronostic, surtout dans les cancers de la gencive mandibulaire. D'accord ? Par localisation, on parle en général, mais certaines localisations, par exemple, sur une atteinte neurologique, c'est un facteur de mauvais pronostic dans les cancers de la gencive.

D'accord ? Ça, c'est des cas du service pour que vous voyiez ce qu'on voit. Les petites lésions que vous avez vues tout à l'heure, on ne les voit jamais, presque. C'est vraiment rare quand on voit des petites lésions.

Ce qu'on voit, c'est ça. C'est une patiente qui est décédée dernièrement, c'est une tumeur endobuccale avec extension au niveau de la peau. Elle a aussi bien une partie du cou, la mandibule, une partie du maxillaire, la joue, la chirurgie impossible.

Pour une chirurgie de propreté, ça veut dire qu'elle est décédée deux mois après l'intervention, je pense. C'est une patiente qui a opéré. On a enlevé la joue, on a enlevé la lèvre, une partie de la lèvre supérieure, une partie de la lèvre inférieure, une partie du menton.

On a fait une première reconstruction, une deuxième reconstruction qui n'a pas réussi pour la lèvre supérieure. Ça fait six mois, on a ces neuf services. C'est des XRS, c'est ça, c'est ce qu'on fait, cancer de la face interne de joue étendu au niveau de la lèvre supérieure et inférieure.

C'est un homme, c'est une femme. Ça, c'est... Quand on va montrer ces images aux patients, ils ne seront pas opérés. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, tu enlèves une qualité de vie qui est merdique, je m'excuse pour le terme, pour lui donner une qualité plus merdique encore.

D'accord ? Qu'est-ce qu'il aura comme qualité de vie là-dedans ? Ni aspect. On va, soi-disant, prolonger un tout petit peu la survie. Parce que si on laisse la tumeur, à la base du crâne, du coup, on aura des problèmes.

Prédisposition génétique, il n'y a pas de prédisposition génétique. Mais surtout, parmi les facteurs de risque, il n'y a pas de prédisposition génétique. Pardon ? Le sarcome, oui.

Oui. Mais le reste, non. Le tumeur carcinome, généralement, le carcinome épidermoïde, non.

C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est l'HPV, en général. L'exposition solaire, d'accord ? Le problème, c'est qu'il y a des patients qui ont un cancer du plancher étendu à la langue et étendu à la mandibule. Donc les coupes que vous voyez, c'est les coupes, c'est la mandibule.

On a enlevé aussi la mandibule. On a enlevé une partie du cou. On a reconstruit par un grand

pectoral.

Il devient mieux, mais pas la meilleure qualité de vie. Le problème, c'est qu'on, des fois, on a des patients de 30 ans. J'ai eu un patient de 30 ans à qui on a enlevé les deux lèvres pour un IHSANI.

J'ai eu un patient de 40 ans qui avait la lèvre inférieure. Il avait deux ans avec un cancer de la lèvre supérieure. C'est ça, le problème.

C'est ce qu'on a. Donc, en conclusion, c'est un cancer qui est très fréquent dans notre contexte. Il est dû essentiellement à l'intoxication alcool-tabagique. Il nécessite un examen clinique à la recherche des signes de présomption tumorale.

La biopsie et l'examen anatomopathologique constituent le diagnostic de certitude. Le traitement doit être multidisciplinaire. Il est essentiellement et le gold standard, c'est la chirurgie, pas le laser, pas la cryothérapie.

Parce que, c'est ce qu'on voit généralement. Il faut toujours indiquer la chirurgie aux patients. Non, non, non.

C'est-à-dire si quelqu'un a des blessures à chaque fois dans le même endroit. C'est-à-dire, quand on a des blessures à la deuxième, à la troisième, à la dixième fois, ça entraîne des traumatismes. Ça ne laisse pas que la lésion cicatrisée.

Donc, le fait de traumatiser à plusieurs reprises, au fur et à mesure, les cellules, elles se multiplient, elles s'éloignent et ça se transforme. D'accord? Généralement, c'est des prothèses. Si quelqu'un a une dent, qui irrite sa langue latéralement, par exemple, un bridge, si quelqu'un fait un petit truc à l'intérieur, il traumatise à chaque fois le bord latéral de sa langue.

La première chose qu'on demande aux patients, c'est de changer le bridge, de changer la prothèse ou la dent enlever carrément la dent. Parce que le micro-traumatisme répété, c'est un facteur de prédisposition au cancer. D'accord? Ou là, quand on a la prothèse, on a bien la lésion.

C'est pour ça qu'il faut enlever toujours les prothèses. La lésion là, qu'on a bien la lésion. Sans tabac.

Comme si on avait un risque de 1 sur 1 million avec l'exposition solaire. Si on ajoute à ça le tabac, on a moins de 100 000. Si on a moins de 100 000, on a moins de 100 000.

Si on a moins d'alcool, on a moins de 100 000. Bien sûr qu'il y a un risque. Mais si c'est diagnostiqué précocement et pris en charge précocement, c'est bien.

Si c'est diagnostiqué tardivement, qui donne aux patients des maladies qui sont et d'une toute une lèvre, ça c'est grave, d'accord? Parce que ça ne sert à rien, c'est une perte d'argent, vous le

connaissiez. Donc la prévention, elle est primaire, secondaire et tertiaire, primaire par la suppression du tabagisme et de l'alcoolisme, par l'amélioration de l'état buccodentaire de tout le monde, surtout les patients prédisposés, les patients tabagiques et alcooliques, la vaccination contre l'HPV qui va, je pense, malheureusement le cancer de la cavité buccale, il n'est pas bien pris en charge, il n'est pas bien médiatisé en Maroc. C'est dans le Canada, l'Amérique, la vaccination contre l'HPV, elle est pour tout le monde, que ce soit adultes, enfants, même les hommes, pour le cancer de la cavité buccale.

Là, l'HPV, c'est surtout pour le cancer du corps, d'accord? C'est quelque chose que j'ai dans les images, ils ne voient pas ça. Si vous voyez ça, ils vont l'instaurer aussi bien pour tout le monde. Donc secondaire, par le dépistage et le traitement précoce des lésions à potentiel malin, lésions précancéreuses, proposer un bilan buccodentaire aux personnes vulnérabilisées par les addictions, former les chirurgiens dentistes à la détection précoce des cancers buccaux, mais aussi les généralistes.

Alors qu'on les voit comme la spécialité, mais si vous restez généraliste, c'est votre obligation de diagnostiquer ces patients. Donc devant toute adénopathie cervicale, il faut chercher un cancer de la cavité buccale. Devant une petite lésion, parce que là j'ai vu des généralistes qui expliquent la lésion.

Lésion tumorale. La patiente, tu la mets sur la lésion. C'est un cancer.

C'est un cancer. J'ai un trente-deux ans. Mais ça existe malheureusement parce que les gens mais quand il devient généraliste l'objectif c'est de gagner de l'argent.

Mais c'est pas parce que non et votre devoir c'est de diagnostiquer ces patients. Parce que la patiente comme ça un dossier C'est ce qui existe alors qu'on aurait pu faire le diagnostic et traiter ces patients précocement. Donc prévention tertiaire c'est de multiplier les centres spécialisés et la formation continue.

Et je vous remercie si vous avez des questions. Pas de questions ? Pour l'examen il sera facile Charles. Ne vous inquiétez pas.

Bon courage.